EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	78777
SERVICIO	:	UTI HSC			
FECHA	:	2024-02-10 14:20:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GLADYS DEL CARMEN GATICA RETAMAL			**RUN**	: 7.320.684-7
F.Nac	: 19-02-1952	**Edad**	: 71 AÑOS, 11 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: V.PRAT IQUIQUE 1322			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 96131367		
Fecha Ingreso	: 2024-02-04	**Fecha Egreso**	: 2024-02-10 14:20:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. S06.5-HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Hematoma Subdural derecho traumático
2. Coagulopatía por TACO resuelta
3. Herida contusa ciliar derecha + contusión malar derecha (18/01/24)
4. FA paroxística en TACO (acenocumarol, suspendido),
5. Fractura humero proximal derecho antiguo (Manejo conservador, caída 27/11/23)
6. Antecedentes: HTA.

Procedimientos realizados: instalación linea arterial

<u>DIAGNÓSTICOS CIE10</u>

1. S06.5-HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. S06.5-HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. D68-OTROS DEFECTOS DE LA COAGULACION (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Usuaria de 71 años, con antecedentes descritos, auto Valente, el día 27 de noviembre sufre caída a nivel, resultando con fractura de húmero derecho, fue evaluada por traumatólogo quien indica que usuaria y familiares rechazan operación. El día 18 de enero nuevamente sufre caída a nivel en su domicilio, golpeándose hemi cara derecha, hombro y antebrazo derecho. Posteriormente se asocia el día miércoles 31/1/2024 comienza con cefalea frontal, y decide consultar el día viernes 02/02/2024 por exacerbación clnica , donde se le realiza tac el cual arrojo hematoma subdural de la convexidad derecha con extensión tentorial ipsilateral y leve efecto de masa, se deriva a chillan para evaluación neurocirujano, quien descarta cuadro quirúrgico. Se indica retorno a Hospital de origen , manejo medico de coagulopatía, monitorizacion de hematoma. Al realizar exámenes de laboratorio se pesquisa INR mayor a 6, por lo que se indica tratamiento con plasma y konakion. Se mantiene en sala UTI sin intercurrencias, con mejoría de cefalea sin focalización neurológica ni deterioro de Glasgow, con plan de cumplir 7-10 dias sin anticoagulación y posterior reinicio durante hospitalización considerando alto riesgo cardiovascular con vigilancia de síntomas neurológicos y neuroimagen .
Actualmente estable, hemodinamia autosostenida sin requerimiento de soporte con DVA, sin apoyo de O2 suplementario, refiere ligera cefalea que cede con paracetamol, con buen control de PA, sin compromiso neurológico, buena tolerancia a la via oral y rehabilitación kinésica. Se realiza TC cerebro el día de hoy 10/02 que muestra buena evolución, sin complicaciones respecto a Tc previos. Se deriva a HODOM para continuar rehabilitación kinésica por antecedente de varias caídas en domicilio, se deja andador.

PLAN DE MANEJO:

HD/CV: mantener control de frecuencia cardiaca y antihipertensivos. INR corregido, mantener sin anticoagulación por HSD, reinicio de anticoagulación por alto riesgo embolico post autorización de Neurocirujano.. Poli cardiología e 1 mes
Ventilatorio: sin conflicto actual
Infeccioso: Parámetros inflamatorios bajos a su ingreso. Sin conflicto.
Renal: sin conflicto, evitar nefrotóxicos.
Metabólico: sin conflicto
Requiere rehabilitación kinésica e iniciar uso andador

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Régimen común
3. Omeprazol 20 mg 1 capsula antes del desayuno vo
4. Paracetamol 1 gr c/8 hrs vo
5. Carvedilol 6,25 mg 1 comprimido c/12hrs vo
6. Losartán 50 mg 1 comp c/12hrs vo
7. Amlodipino 10 mg 1 comprimido al día vo
8. Atorvastatina 20 mg 1 comprimido en la noche vo
9. HODOM para rehabilitación kinésica

10. Tramitar andador lunes por familia (dejo orden)
11. Control CAE con Neurocirujano en 10 días (pendiente definir fecha de inicio anticoagulación)
12. Control CAE cardiología en 1 mes

EXÁMENES Y RESULTADOS

TC cerebro 10/02/24: menor densidad de la colección subdural supratentorial derecha respecto a control previo. resto de estudio sin hallazgos destacables.

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO